

Conduit iléal (Bricker)

WARWIKI

Information pour le patient · Une dérivation urinaire drainant dans une poche de stomie

Un conduit iléal est un moyen de drainer l'urine après l'ablation de la vessie ou lorsqu'elle ne fonctionne plus. Le chirurgien utilise un court segment de votre propre intestin pour acheminer l'urine des reins vers une petite ouverture sur votre abdomen (une stomie), où elle s'écoule dans une poche légère que vous portez. Il s'agit de la dérivation urinaire la plus simple et la plus courante.

À propos de cette intervention

Un **segment d'intestin grêle de 15–20 cm** sert de **conduit** — il ne stocke pas l'urine. Les uretères (les tubes reliant les reins) y sont raccordés, et une extrémité est amenée à la peau sous forme de **stomie**, généralement dans le bas-ventre à droite. Comme l'urine s'écoule **en continu**, vous portez une poche légère (une **poche de stomie**) sur la stomie, que vous videz plusieurs fois par jour et changez tous les quelques jours.

- Il n'y a **rien à contrôler et aucun sondage à effectuer**.
- Le reste de votre intestin est **reconnecté** afin que la digestion se poursuive normalement.
- Une **infirmière stomathérapeute** vous apprend à prendre soin de la stomie et de la poche.

Est-ce sans danger ?

Le conduit iléal est la dérivation continente standard depuis plus de 70 ans — c'est la technique la plus simple, avec l'opération la plus courte. Comme toute chirurgie majeure, elle comporte des risques (saignement, infection, fuite au niveau des sutures intestinales ou urétérales). Avec le temps, certaines personnes présentent des problèmes de stomie ou de peau, des infections urinaires, ou des variations de sel et de vitamines — tout cela est surveillé lors des consultations de suivi.

COMPRENDRE LES TERMES

Dérivation urinaire

Un nouveau trajet pour que l'urine quitte l'organisme lorsque la vessie est absente ou ne fonctionne plus.

Conduit iléal

Court segment d'intestin grêle acheminant l'urine vers une stomie.

Stomie

La petite ouverture sur l'abdomen, faite d'intestin, par laquelle l'urine s'écoule.

Poche de stomie

La poche portée sur la stomie pour recueillir l'urine.

Uretères

Les tubes qui acheminent l'urine des reins ; ils sont reliés au conduit.

Infirmière stomathérapeute

Infirmière qui repère l'emplacement de la stomie et enseigne les soins de stomie et de poche.

Mucus

Fluide glissant produit par l'intestin ; des filaments dans l'urine sont normaux.

Peau péristomiale

La peau autour de la stomie, maintenue propre et protégée.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération est réalisée sous anesthésie générale, vous ne ressentez donc rien pendant l'intervention. Ensuite, attendez-vous à des douleurs abdominales, et l'intestin met quelques jours à « se réveiller » (vous commencez par des liquides, puis progressez). La stomie elle-même ne ressent rien. La plupart des patients restent hospitalisés environ 5–7 jours.

Comment vous préparer (avant la chirurgie)

- L'intervention se déroule sous **anesthésie générale** — suivez toutes les instructions chirurgicales (jeûne, et médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants). Une **préparation intestinale** peut être requise.
- Rencontrez l'**infirmière stomathérapeute**, qui repère le meilleur emplacement pour votre stomie pendant que vous êtes assis, debout et allongé — c'est essentiel pour un ajustement confortable et sans fuite.
- **Ne fumez pas** — cela ralentit la cicatrisation — et organisez de l'aide à domicile pour après.

Informez votre équipe soignante à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection en cours
- Avez une **maladie intestinale** (comme la maladie de Crohn ou une colite), des antécédents de chirurgie abdominale ou de radiothérapie

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi sous anesthésie et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Un court segment d'intestin est isolé et le reste est reconnecté.
- 3 Les uretères sont raccordés au segment intestinal.
- 4 Une extrémité est amenée à travers l'abdomen en stomie ; des sondes souples et un drain sont mis en place pendant la cicatrisation.

Après la chirurgie

- Retour à la maison après environ **5–7 jours**. La stomathérapeute vous apprend à **vider la poche** (plusieurs fois/jour) et à **changer l'appareillage** (tous les quelques jours).
- Des filaments de **mucus** dans l'urine sont normaux — l'intestin en produit.
- **Buvez beaucoup** et prenez soin de la peau autour de la stomie.
- **Évitez les efforts lourds pendant environ 6 semaines**. Des contrôles à vie sont nécessaires (fonction rénale, vitamine B12).

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- La stomie qui devient **sombre, violacée ou se rétracte**
- **Peu ou pas d'urine** dans la poche pendant plusieurs heures
- Des douleurs abdominales intenses, des vomissements, ou **absence de gaz ou de selles** (intestin bloqué)
- Saignement abondant, ou rougeur ou écoulement au niveau de la plaie

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Un conduit iléal utilise un court segment d'intestin pour drainer l'urine vers une stomie abdominale dans une poche — la dérivation la plus simple, sans sondage.
2. Pour vous préparer : jeûne et préparation intestinale, rencontre avec la stomathérapeute, pas de tabac, et aide à domicile.
3. Le mucus dans l'urine est normal ; l'infirmière stomathérapeute vous guidera pour les soins de poche et de peau.